

Colocación de sonda suprapúbica

WARWIKI

Información para el paciente · Qué esperar antes de su procedimiento

Una sonda suprapúbica — también llamada tubo suprapúbico o “SPT” por sus siglas en inglés — es un tubo blando que drena la orina de su vejiga a través de una pequeña abertura en la parte baja del abdomen, justo encima del hueso púbico, en lugar de hacerlo por la uretra. Esta hoja explica por qué se coloca, cómo prepararse y qué esperar.

Acerca de este procedimiento

La vejiga almacena la orina. Cuando la orina no puede drenar de la manera habitual — o la uretra necesita descansar o ser evitada — se puede colocar una sonda directamente en la vejiga a través de la parte baja del abdomen. Como evita la uretra, un tubo suprapúbico suele ser más cómodo para el uso a largo plazo y es más suave con la uretra que una sonda común.

Su equipo de atención puede recomendar un tubo suprapúbico para:

- Drenar la vejiga cuando usted no puede vaciarla por sí mismo
- Dar descanso o proteger la uretra después de una cirugía o una lesión
- Brindar un drenaje cómodo a largo plazo (por ejemplo, con una afección de la vejiga relacionada con los nervios)
- Evitar la irritación que puede causar una sonda a largo plazo a través de la uretra
- Permitir la actividad sexual normal y las “pruebas de micción” (el tubo se puede tapar para probar si usted orina)

¿Es seguro?

Sí. Es un procedimiento común y, en general, seguro. Para mantenerlo seguro, se llena su vejiga para que se eleve contra la pared del abdomen, y su equipo suele usar ecografía o una pequeña cámara para guiar el tubo lejos del intestino. La mayoría de los problemas — un poco de sangrado, molestias leves o calambres de la vejiga — son menores y se resuelven rápido. Avise a su equipo si ha tenido cirugía previa del abdomen o de la pelvis, ya que esto requiere cuidado adicional.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Suprapúbico

Encima del hueso púbico, en la parte baja del abdomen — donde sale el tubo.

Vejiga

El órgano que almacena la orina hasta que usted la vacía.

Sonda

Un tubo blando que drena la orina. Una sonda suprapúbica drena a través del abdomen en lugar de la uretra.

Uretra

El tubo que normalmente lleva la orina fuera del cuerpo. Un tubo suprapúbico la evita.

Anestésico local

Medicina que adormece la piel para que la zona no duela.

Sedación / anestesia

Medicina para relajarlo, o para hacerlo dormir (anestesia general), durante el procedimiento.

Ecografía / cámara

Herramientas (imágenes por ondas de sonido, o una pequeña cámara en la vejiga) que se usan para guiar el tubo de forma segura.

Espasmo de la vejiga

Un calambre repentino de la vejiga — común después y tratable.

¿LE DOLERÁ? Depende del método: algunas colocaciones usan medicina para adormecer con sedación; muchas se hacen bajo **anestesia general o raquídea**, así que usted está dormido o adormecido. Su equipo le dirá cuál. Es normal tener algunos calambres de la vejiga o dolor en el sitio después. El procedimiento toma unos 15–30 minutos.

Cómo prepararse (antes de su procedimiento)

- **Venga con la vejiga llena si se lo piden** — hace que la colocación sea más segura. Su equipo puede pedirle que beba agua y aguante la orina, o le llenará la vejiga al inicio.
- **Siga cualquier indicación de ayuno** — si va a recibir sedación o anestesia general, es posible que le pidan no comer ni beber durante varias horas antes.
- **Organice quién lo lleve a casa** si va a recibir sedación.

Avise a su equipo con anticipación si usted:

- Ha tenido alguna **cirugía del abdomen o de la pelvis** — el tejido cicatricial puede cambiar la ruta más segura para el tubo
- Toma un **anticoagulante** o tiene un problema de sangrado — a menudo se suspenden antes del procedimiento
- Podría estar **embarazada**, o tiene una infección o una alergia a la anestesia o al látex

Qué sucede durante el procedimiento

- 1 Lo colocan en posición y le dan anestesia — medicina para adormecer con sedación, o anestesia general o raquídea. Luego se limpia y se prepara la parte baja del abdomen.
- 2 Se llena su vejiga con líquido (si aún no está llena) para que se eleve contra la pared del abdomen, lejos del intestino.
- 3 Guiado por ecografía o una pequeña cámara en la vejiga, su equipo hace una pequeña incisión justo encima del hueso púbico y pasa el tubo a la vejiga.
- 4 Se infla un pequeño balón dentro de la vejiga para sostener el tubo en su lugar, y se conecta a una bolsa de drenaje.

Después del procedimiento

- La orina drena a una bolsa, y su equipo le **mostrará cómo cuidar el tubo y el sitio de la piel** antes de que se vaya a casa.
- Es común tener un dolor leve, calambres de la vejiga o **un poco de sangre en la orina** por uno o dos días.
- El **primer cambio del tubo lo hace su equipo**, unas 4–6 semanas después. Si el tubo se sale, comuníquese con su equipo de inmediato — el canal puede cerrarse en cuestión de horas.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- El tubo **se sale**, o deja de drenar (no hay orina en la bolsa)
- Dolor abdominal en aumento, hinchazón o sangrado abundante
- Orina turbia y con mal olor (una señal de infección)

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Un tubo suprapúbico drena su vejiga a través de una pequeña abertura en la parte baja del abdomen, evitando la uretra — a menudo más cómodo para el drenaje a largo plazo.
2. Para prepararse: venga con la vejiga llena si se lo piden, siga el ayuno indicado, organice quién lo lleve si recibe sedación, y avise sobre cirugía abdominal previa, anticoagulantes o posible embarazo.
3. Se hace con anestesia local y sedación, o general. Su equipo le enseña a cuidar el tubo y hace el primer cambio a las ~4–6 semanas. Llame si el tubo se sale, hay fiebre o no drena orina.